

اسپوندیلوارتروپاتی پارت سه

۱- خانم ۳۰ ساله با پلی آرتریت مفاصل DIP ، PIP ، و مچ (wrist) به همراه Pitting ناخن‌ها و ضایعات پوستی قرمز رنگ با پوسته‌ریزی روی آرنج‌ها و زانو‌ها مراجعه کرده است. کدام یک از عبارات زیر در مورد این بیماری صحیح نمی‌باشد؟

الف) انکیلوز مفصلی از آرتریت روماتوئید شایع‌تر است.

ب) توزیع اشعه‌ای مانند (Ray distribution) جزء تظاهرات این بیماری است.

ج) آنتی CCP می‌تواند مثبت شود.

د) درگیری پوستی ناخنی اغلب همزمان با درگیری مفصلی رخ می‌دهد.

پاسخ تشریحی: گزینه د

بر اساس علائم بالینی که شامل پلی آرتریت مفاصل DIP ، PIP ، و مچ (wrist) ، Pitting ناخن‌ها، و ضایعات پوستی قرمز رنگ با پوسته‌ریزی روی آرنج‌ها و زانو‌ها است، تشخیص محتمل آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis - PsA) می‌باشد. ضایعات پوستی پسوریازیس اغلب در نواحی مانند آرنج و زانو دیده می‌شوند. درگیری مفاصل DIP ، PIP و مچ می‌تواند در الگوهای مختلف درگیری مفصلی PsA (الیگوارتریت یا پلی آرتریت) مشاهده شود. درگیری ناخنی مانند Pitting نیز از تظاهرات شایع PsA است که اغلب در انگشتان درگیر مفصلی دیده می‌شود.

الف) در مقایسه PsA با RA بیان می‌کند که "PsA تمایل بیشتری به ایجاد انکیلوز در مفاصل کوچک" در مقایسه با RA دارد. این نشان می‌دهد که انکیلوز مفصلی در PsA، به خصوص در مفاصل کوچک، تمایل بیشتری برای وقوع نسبت به RA دارد.

ب) درگیری مفاصل به صورت "ray distribution" را به عنوان یکی از ویژگی‌های افتراق دهنده PsA ذکر می‌کند و آن را "characteristic" می‌داند. مثالی که زده می‌شود درگیری کامل یک انگشت در یک دست است در حالی که انگشتان دیگر درگیر نیستند.

ج) در بخش یافته‌های آزمایشگاهی PsA بیان می‌کند که "درصد کمی از بیماران ممکن است RF و ANA مثبت داشته باشند" و "۱۰٪ بیماران ممکن است anti-CCP مثبت باشند". بنابراین، آنتی CCP می‌تواند در PsA مثبت شود.

د) درگیری پوستی ناخنی اغلب همزمان با درگیری مفصلی رخ می‌دهد. منبع ۹ در خصوص زمان بروز تظاهرات در PsA توضیح می‌دهد:

• ۷۰٪ موارد: پسوریازیس (پوستی) ابتدا و سپس درگیری مفصلی رخ می‌دهد.

• ۱۵٪ موارد: ضایعات پوستی و تظاهرات مفصلی در عرض یک سال ایجاد می‌شود (ممکن است نزدیک به هم یا همزمان تلقی شود).

• ۱۵٪ موارد: ابتدا آرتریت پیدا می‌کنند و سپس دچار پسوریازیس پوستی می‌شوند. عبارت "اغلب همزمان با درگیری مفصلی رخ می‌دهد" با توجه به اینکه در ۷۰٪ موارد درگیری پوستی قبل از درگیری مفصلی رخ می‌دهد، و تنها ۱۵٪ موارد در عرض یک سال (که ممکن است همزمان تلقی شود) رخ می‌دهند. اکثریت موارد، درگیری پوستی مقدم بر درگیری مفصلی است.



۲- کدام جمله در مورد اسپوندیلیت آنکیلوزان در خانم‌ها صحیح است؟

الف) احتمال AS Non-radiographic در آن‌ها بیشتر است.

ب) درگیری ستون فقرات کمری از گردنی شایع‌تر است.

ج) در طی حاملگی بیماری در بیشتر از نیمی از موارد شدید می‌شود.

د) انتریت کمتر دیده می‌شود.

پاسخ تشریحی: گزینه الف

اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) در خانم‌ها معمولاً با الگوی متفاوتی نسبت به مردان بروز می‌کند:

ویژگی‌های شایع در زنان:

• فرم Non-radiographic axial SpA (بدون شواهد واضح رادیولوژیک) شایع‌تر است

• درد ممکن است غیرتیبیک و پراکنده‌تر باشد

• درگیری گردنی ممکن است نسبت به کمری شایع‌تر باشد

• انتریت و کرون یا دیگر بیماری‌های التهابی روده‌ای در آن‌ها همچنان ممکن است دیده شود

• تغییرات فعالیت بیماری در حاملگی متغیر است؛ نه الزاماً شدیدتر

۳- در مورد درگیری چشمی در آرتریت پسوریاتیک (PSA)، کدام جمله صحیح است؟

الف) اسکلریت جزو تظاهرات چشمی PSA نمی‌باشد.

ب) یووئیت در PSA بیشتر خلفی و دو طرفه است.

ج) پروگنوز یووئیت در PSA نسبت به AS بهتر است.

د) یووئیت در PSA بیشتر قدامی و یک طرفه است

پاسخ تشریحی: گزینه ب

الف: در جزوات و هاریسون اشاره نشده به اسکلریت فقط ذکر شده که تظاهرات یووئیت در PSA به شکل خلفی و دوطرفه است.

ب: بله

ج: منبع در مورد پروگنوز یووئیت در PSA می‌گوید: "پروگنوز بدتری مزمن می‌شود و دارد و بیشتر به سمت کوری می‌رود"

د: اینم غلط هستش گزینه الف را بخوانید.



۴- در بیماران با سندرم Seronegative Enthesopathy and Arthropathy (SEA) ، کدام مورد صدق می کند؟

الف) بیماری کمتر از نیمه از بیماران به سمت اسپوندیلیت آنکیلوزان پیشرفت می کنند.

ب) بیماری در دختران شایع تر از پسران است.

ج) HLA-B27 در اغلب بیماران منفی است.

د) درگیری ستون فقرات معمولاً در بزرگسالی دیده می شود.

پاسخ تشریحی: گزینه د

الف: در بزرگسالی و اواخر نوجوانی، درصد بالایی از بیماران مبتلا به Juvenile onset spondyloarthropathy که SEA نامیده می شود به سمت AS می روند.

ب: بیماری (Juvenile onset spondyloarthropathy) در پسر بچه ها شیوع بیشتری نسبت به دختر بچه ها دارد حدود ۶۰-۸۰٪.

ج: ۸۰٪ بیماران HLA-B27 مثبت هستند

د: درگیری قابل توجه ستون فقرات اغلب به عنوان بخشی از پیشرفت بیماری در سنین بالاتر (اواخر نوجوانی و بزرگسالی) رخ می دهد

۵- قای ۲۴ ساله با سابقه کمردرد از ۴ ماه قبل مراجعه کرده است. درد به صورت متناوب بین دو باسن وجود دارد، با فعالیت کم بهتر می شود. بیمار معمولاً از شدت درد بین ساعت ۳ الی ۴ صبح از خواب بیدار می شود و برای بهبود باید چند دقیقه ای راه برود یا از مسکن استفاده کند. وی خشکی صبحگاهی در حد ۴۵ دقیقه را ذکر می کند. بیمار چند معیار کمردرد التهابی را داراست؟

پاسخ تشریحی:

شروع در سن کمتر از ۴۰ سال

شروع تدریجی درد

بهبود با فعالیت، نه با استراحت

درد شبانه که با برخاستن بهبود یابد

سفتی صبحگاهی بیش از ۳۰ دقیقه



۶- آقای ۲۸ ساله با درد و تورم و قرمزی زانوی چپ و تاندون آشیل راست که از یک هفته قبل شروع شده، مراجعه کرده است. وی سابقه عفونت تناسلی را تقریباً یک ماه قبل از شروع درگیری مفصل ذکر می‌کند. در معاینه زخم دهانی و راش ندارد. در رادیوگرافی لگن و مفاصل نیز نکته خاصی دیده نمی‌شود. شمارش سلول‌های خونی نرمال است. کدامیک از تشخیص‌های زیر بیشتر برای بیمار مطرح است؟

(الف) آرتریت راکتیو

(ب) عفونت گنوکوکی منتشر

(ج) اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS)

(د) لوپوس اریتماتوی سیستمیک

پاسخ تشریحی: گزینه الف

شرح حال بیمار به‌ویژه با شروع حاد آرتریت پس از یک عفونت تناسلی (به‌خصوص چلامیدیا)، درگیری مفصل محیطی بزرگ (زانوی چپ) و آنتزیت (تاندون آشیل راست)، بسیار کلاسیک برای آرتریت راکتیو است:

- مرد جوان
- شروع آرتریت حدود ۱ تا ۴ هفته پس از عفونت ادراری تناسلی یا گوارشی
- آنتزیت و اولیگوآرتریت (درگیری مفاصل بزرگ اندام تحتانی)
- راش و زخم مخاطی در این بیمار دیده نمی‌شود، اما الزامی نیست
- لوپوس و اسپوندیلیت آنکیلوزان معمولاً تظاهرات مزمن‌تر دارند
- عفونت گنوکوکی اغلب چندمفصلی و همراه با تب یا راش می‌باشد

۷- آقای جوان با سابقه درد پاشنه‌ها و کمردرد التهابی از یک سال قبل مراجعه کرده است. در معاینه حرکات کمر محدود شده و دردناک است. در لمس ساکروایلیاک دو طرف و قفسه سینه تندرست وجود دارد. کدام اقدام تشخیصی ارجح است؟

(الف) رادیوگرافی قفسه سینه

(ب) بررسی HLA-B۲۷

(ج) ESR

(د) رادیوگرافی مهره‌های کمر

پاسخ تشریحی: گزینه ب

الف: اگرچه آنتزیت در قفسه سینه ممکن است در اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها دیده شود، اما رادیوگرافی قفسه سینه به تنهایی اقدام تشخیصی ارجحی برای تشخیص کلی بیماری زمینه‌ای در این مرحله نیست.

ب: این آنتی‌ژن ارتباط قوی با اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) که شایع‌ترین اسپوندیلوآرتروپاتی محوری است، دارد؛ به‌طوری که ۹۰ تا ۹۲ درصد بیماران مبتلا به AS آن را مثبت هستند. همچنین در آرتریت راکتیو (Reactive Arthritis) که می‌تواند با درگیری محوری و آنتزیت همراه باشد، ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران HLA-B۲۷ مثبت هستند. مثبت بودن HLA-B۲۷ به تنهایی تشخیص قطعی اسپوندیلوآرتروپاتی نیست، اما وجود آن همراه با علائم

بالینی قویاً مطرح کننده این گروه از بیماری‌ها است. در معیارهای طبقه‌بندی ASAS برای اسپوندیلوآرتروپاتی محوری، مثبت بودن HLA-B27 به همراه دو یا چند ویژگی اسپوندیلوآرتروپاتی (که این بیمار چند مورد از آن‌ها را دارد، مانند کمردرد التهابی، انتزیت) می‌تواند به طبقه‌بندی بیماری کمک کند، به خصوص اگر تصویربرداری مفاصل ساکروایلیاک منفی باشد.

ج: یک واکنش گر فاز حاد و یک نشانگر غیر اختصاصی التهاب است. اگرچه معمولاً در اسپوندیلوآرتروپاتی فعال افزایش می‌یابد. اما طبیعی بودن آن تشخیص را رد نمی‌کند. و به اندازه HLA-B27 در مطرح کردن تشخیص اسپوندیلوآرتروپاتی اختصاصی نیست.

د: در اسپوندیلیت آنکیلوزان، درگیری اصلی در ستون فقرات و مفاصل ساکروایلیاک است. اگرچه تغییرات رادیوگرافیک در مهره‌های کمری مانند مربع شدن مهره‌ها یا سندسوفیت‌ها در AS دیده می‌شود. اما اغلب اوقات اولین شواهد رادیوگرافیک در مفاصل ساکروایلیاک ظاهر می‌شوند. با توجه به تندرست دوطرفه در مفاصل ساکروایلیاک در این بیمار، رادیوگرافی مفاصل ساکروایلیاک اقدام تشخیصی اولیه ارجح در تصویربرداری است تا ساکروایلیت رادیوگرافیک بررسی شود. رادیوگرافی مهره‌های کمری بیشتر برای بررسی تغییرات پیشرفته‌تر ستون فقرات انجام می‌شود و ممکن است در مرحله یک ساله بیماری هنوز تغییرات مشخصی نداشته باشد.

۸- خانم ۴۵ ساله‌ای به علت درد و تورم زانو‌ها مراجعه کرده. در معاینه التهاب در مفاصل DIP هر دو دست و برخی از PIP ها دیده می‌شود. ضایعات اریتماتو-اسکواموس (psoriasiform) در سطح اکستنسورها و تغییرات ناخنی (هایپرکرتوز و فرورفتگی‌ها) وجود دارد. در آزمایشات Anti-CCP و RF منفی بوده‌اند. با توجه به این اطلاعات بیمار از نظر معیارهای CASPAR چند امتیاز می‌گیرد؟

پاسخ تشریحی:

معیارهای CASPAR برای تشخیص آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis) بر اساس امتیازدهی است. در صورت داشتن حداقل ۳ امتیاز، تشخیص آرتریت پسوریاتیک مطرح می‌شود.

بر اساس اطلاعات بیمار:

۱. درگیری مفاصل DIP: امتیاز ۱
۲. ضایعات پوستی پسوریازیس فعال: امتیاز ۲
۳. درگیری ناخنی (nail dystrophy) مثل pitting یا onycholysis: امتیاز ۱
۴. منفی بودن RF: ۱ امتیاز

ابوالفضل جعفری - MEDQMUMS

